

## **ALLERGIES ALIMENTAIRES CHEZ L'ENFANT**

### **Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire?**

Une allergie se produit lorsque le système immunitaire réagit à une substance consommée (un allergène) en libérant une substance chimique (histamine) dans l'organisme. L'histamine est la cause des symptômes gênants (comme les picotements dans la bouche ou la gorge, l'urticaire, la diarrhée, les crampes ou les nausées) ou parfois des symptômes dangereux (comme l'enflure du visage ou de la langue, ou des difficultés à respirer). Ce type de réaction peut se produire subitement ou dans les deux heures suivant la consommation d'un allergène alimentaire.

### **Quelles sont les allergies alimentaires les plus fréquentes?**

Les plus fréquentes sont les allergies aux arachides, au poisson, au lait, au soja, au blé, aux noix (par exemple noix de Grenoble, amandes, pacanes), aux œufs, aux crustacés et à la moutarde.

### **Comment savoir si mon enfant est allergique à un aliment?**

Le plus souvent, votre enfant aura été exposé à un aliment plus d'une fois avant de savoir s'il y est allergique. Si votre enfant présente des symptômes allergiques (décrits ci-dessus) après avoir consommé un aliment en particulier, ceux-ci peuvent être dus à une allergie alimentaire, mais ce n'est pas toujours le cas.

### **Est-il possible de prévenir les allergies alimentaires?**

Autrefois, on demandait aux parents de retarder l'introduction d'aliments jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de six mois, afin de prévenir une allergie alimentaire. Le conseil a changé : il ne faut pas retarder l'introduction d'aliments même chez les enfants dont un parent ou un frère ou une sœur est allergique à un aliment. En fait, l'introduction précoce des aliments, par exemple les arachides, peut aider à prévenir les allergies. N'oubliez pas qu'une fois que vous donnez ces aliments à votre enfant, il est important de continuer à le faire de façon régulière.

**Remarque :** Il ne faut jamais donner de miel à un enfant de moins d'un an. La raison n'est pas liée aux allergies alimentaires mais au risque qu'un jeune enfant attrape une bactérie (botulisme) présente dans le miel.

Le fait d'éviter des aliments tels que le lait, les œufs ou les arachides pendant la grossesse ou l'allaitement ne préviendra PAS des allergies alimentaires chez votre enfant. En outre, aucune donnée ne prouve que les préparations à base de soja préviennent les allergies.

### **Les allergies alimentaires finissent-elles par disparaître chez les enfants?**

Parfois oui; c'est particulièrement le cas des allergies au lait et aux œufs. Les enfants atteints d'autres allergies alimentaires, par exemple aux arachides ou à d'autres noix et au poisson, pourraient ne jamais s'en débarrasser.

### **Quand dois-je emmener mon enfant chez le médecin?**

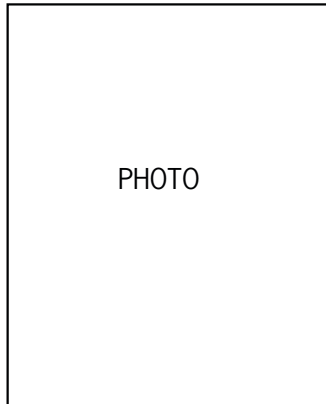
Si votre enfant semble faire une réaction à un certain aliment, consultez votre médecin de famille; celui-ci vous interrogera sur la réaction et vous demandera si votre enfant ou un membre de votre famille a déjà eu des allergies. Vos réponses l'aideront à déterminer si votre enfant a besoin d'analyses de sang ou d'être orienté chez un allergologue pour passer d'autres tests et d'autres examens diagnostiques.

**Sources :** **1)** Food allergy vs. food intolerance: What is the difference and can I prevent them? Canadian Pediatric Society. <http://www.caringforkids.cps.ca> ; **2)** Government of Canada. Food Allergies. 2015 <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-allergies-intolerances/food-allergies.html> ; **3)** HealthLink BC. Food Allergies. 2018 <https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7016>



# Plan d'urgence en cas d'anaphylaxie : \_\_\_\_\_ (nom)

Cette personne présente une allergie potentiellement mortelle (anaphylaxie) à :



(Veuillez cocher les cases pertinentes)

☐ Aliment(s) : \_\_\_\_\_

☐ Piqûres d'insectes

☐ Autre : \_\_\_\_\_

**Auto-injecteur d'épinéphrine** : Date d'expiration \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Posologie** :

☐ EpiPen® Jr. 0,15 mg ☐ EpiPen® 0,30 mg

**Lieu d'entreposage du (des) auto-injecteur(s)** : \_\_\_\_\_

☐ **Réaction anaphylactique antérieure** : La personne est exposée à un risque accru.

☐ **Asthmatique** : La personne est exposée à un risque accru. Si une personne fait une réaction et éprouve des difficultés à respirer, administrer d'abord l'épinéphrine par auto-injecteur avant de donner un médicament contre l'asthme.

Une personne présentant une réaction anaphylactique peut afficher N'IMPORTE LEQUEL des signes et symptômes suivants :

- **Peau** : urticaire, enflure (visage, lèvres, langue), démangeaisons, chaleur, rougeur
- **Appareil respiratoire (respiration)** : toux, respiration sifflante, essoufflements, douleur ou serrement à la poitrine, serrement à la gorge, voix rauque, congestion nasale ou symptômes ressemblant au rhume des foins (écoulement nasal, démangeaisons au nez et larmolement, éternuement), difficulté à avaler
- **Système gastro-intestinal (ventre)** : nausées, douleur ou crampes, vomissements, diarrhée
- **Appareil cardiovasculaire (cœur)** : peau plus pâle que d'habitude/de couleur bleue, pouls faible, évanouissement, étourdissements ou sensation de tête légère, choc
- **Autres** : anxiété, catastrophisme (sentiment que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire), maux de tête, crampes utérines, goût métallique

La reconnaissance rapide des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver la vie d'une personne.

Agissez rapidement. Les premiers signes d'une réaction peuvent être légers, mais les symptômes peuvent s'aggraver très rapidement.

1. **Administrer l'épinéphrine par auto-injecteur** (p. ex., EpiPen®) au premier signe d'une réaction anaphylactique avérée ou soupçonnée. (Voir le feuillet d'instructions ci-joint.)
2. **Composer le 9-1-1** ou les services médicaux d'urgence locaux. Leur dire que quelqu'un fait une réaction allergique potentiellement mortelle.
3. **Administrer une seconde dose d'épinéphrine** cinq minutes seulement après l'administration de la première dose si les symptômes ne s'atténuent pas.
4. **Se rendre immédiatement à l'hôpital le plus proche (idéalement en ambulance)**, même si les symptômes sont légers ou s'ils ont disparu. La réaction pourrait s'aggraver ou réapparaître, même après un traitement adéquat. Rester à l'hôpital pendant la durée d'observation nécessaire décidée par le médecin du service d'urgence (en général de quatre à six heures).
5. **Contacter la personne-ressource d'urgence (p. ex., parent ou tuteur).**

## Personne à contacter en cas d'urgence

| Nom | Relation | Numéro téléphone à domicile | Numéro téléphone au travail | Numéro de cellulaire |
|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     |          |                             |                             |                      |
|     |          |                             |                             |                      |
|     |          |                             |                             |                      |

Le patient, le parent ou le tuteur soussigné autorise tout adulte à administrer de l'épinéphrine à la personne susnommée en cas de réaction anaphylactique, de la manière décrite ci-dessus. Ce protocole a été recommandé par le médecin du patient.

Signature du patient/parent/tuteur

Date

Signature du médecin ☐ En dossier

Date

